

早期家庭护理干预对阿尔茨海默病患者生活质量的影响

谭晓雪, 林春洁, 招丽温, 陈汝兰, 杨冰玉, 黄菊兰, 刘红瑞

【摘要】 目的 探讨早期家庭护理干预对提高早、中期阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)患者生活自理能力和生活质量的效果。**方法** 将 52 例早、中期 AD 患者按随机数字法分为观察组和对照组, 每组各 26 例。对照组患者采用常规出院指导, 出院后不进行任何护理干预。观察组患者及照顾者进行 AD 疾病知识和护理技能宣教、心理护理、家居安全、康复训练等遵医嘱行为的家庭护理干预。两组患者干预前后分别采用精神状态量表(mini mental state examination, MMSE)、日常生活能力量表(activities of daily living, ADL)、健康状况调查问卷(SF-36)进行评定。**结果** 干预后观察组患者 ADL 为 (15.86 ± 3.81) 分, SF-36 综合评分为 (578.3 ± 142.4) 分, 均高于对照组患者, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。观察组患者 MMSE 得分为 (16.12 ± 2.84) 分, 与对照组患者相比差异有统计学意义 ($P < 0.01$)。干预后观察组患者在躯体健康、社会功能、躯体角色功能、躯体疼痛、心理健康、情绪角色功能、精力和总体健康 8 个维度及综合评分上与对照组患者的差异有统计学意义 ($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$)。**结论** 有效的家庭护理干预可提高 AD 患者的生活自理能力和生活质量, 改善其心理调适能力, 延缓了病情进展。

【关键词】 阿尔茨海默病; 家庭护理; 生活质量

【中图分类号】 R749.1⁺6 **【文献标志码】** A **【文章编号】** 1008-9993(2010)2A-0176-04

Effects of Early Family Nursing Intervention on Quality of Life of Patients with Alzheimer's Disease

Tan Xiao-xue, Lin Chun-jie, Zhao Li-wen, Chen Ru-lan, Yang Bing-yu, Huang Ju-lan, Liu Hong-rui
(Neurology Department, No. 3 Peoples Hospital of Foshan, Foshan 528000, Guangdong Province, China)

【Abstract】 Objective To investigate the effects of early family nursing intervention on the quality of life of patients with Alzheimer's disease (AD) at early and middle stage. **Methods** Fifty-two patients diagnosed with early or mid-term AD were equally randomized into the observational group and the control group. The control group received routine discharged guidance without any post-discharge nursing intervention. Besides routine guidance, the patients and caregivers of the observational group received family nursing intervention, such as education and nursing skills training of treatment compliance on AD, psychological nursing, home safety nursing, rehabilitation training. Before and after the intervention, mini mental state examination (MMSE), activities of daily living (ADL) and health survey questionnaire (SF-36) were employed to evaluate the quality of life of patients in the two groups. **Results** After intervention, the ADL score of the observational group and the composite score of SF-36 were 15.86 ± 3.81 and 578.3 ± 142.4 respectively, which were both significantly higher than that of the control group ($P < 0.05$). The MMSE score of the observational group was 16.12 ± 2.84 , which was significantly different from that of the control group ($P < 0.01$); Significant differences were observed on the eight domains somatic health, social function, somatic role function, somatic pain, psychological health emotional role function, the general health and energy between the observational group and the control group ($P < 0.05$ or $P < 0.01$). **Conclusion** Family nursing intervention can improve the self-care ability, quality of life and psychological adaptation ability and alleviate their illness advances of the patients with early or mid-term AD.

【Key words】 Alzheimer's disease; family nursing intervention; quality of life

[Nurs J Chin PLA, 2010, 27(2A): 176-179]

阿尔茨海默病 (Alzheimer's disease, AD) 即老年性痴呆, 是由于脑功能障碍而产生的获得性、全面性、持续性的智能障碍综合征, 是老年人继心脏病、

肿瘤和脑血管疾病之后的第 4 位死因^[1]。目前我国 AD 患者约 600 万, 每年有近百万新发病例, 估计到 2050 年, 可达到 2500 万, 将成为影响家庭和社会发展的一个重要制约因素^[2-3]。到目前为止, 对 AD 患者尚无特效治疗手段, 其临床症状呈现不可逆的渐进衰退。采用非药物治疗和良好的护理可有效延缓

基金项目: 广东省佛山市科技局立项课题(200804024)

作者单位: 528000 广东佛山, 佛山第三人民医院神经内科

作者简介: 谭晓雪, 本科, 副主任护师, 主要从事神经内科护理

病情进展,改善症状,提高生存和生活质量。为寻找有效的家庭康复护理,以提高社区 AD 患者的生活自理能力和生活质量,已成为我国面临的一个十分严重而又迫切需要解决的公共卫生问题^[3-4]。鉴此,笔者于 2008 年 6 月至 2009 年 5 月对早、中期 AD 患者实行家庭护理干预,效果满意,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 临床对象 选择 2008 年 6 月至 2009 年 5 月在我院神经内科和老年科住院的 AD 患者。纳入标准:(1)通过简易精神状态检查量表(mini mental state examination, MMSE)测评,符合 CCMD-3 关于老年性痴呆^[5]的诊断标准。(2)采用临床痴呆评定量表(clinical dementia rating scale, CDR)评定,筛选出早、中期 AD 患者。排除严重躯体疾病所致功能障碍、言语沟通障碍,其他类型痴呆和晚期 AD。符合标准患者 52 例,其中男 20 例,女 32 例,年龄 56~79 岁,平均 (68.43 ± 6.01) 岁;病程 1~8 年,平均 (5.34 ± 1.24) 年。文化程度:文盲 9 例,小学 19 例,初中 13 例,高中以上 11 例。早期 22 例,中期 30 例。按随机数字法将 52 例患者分为观察组和对照组,每组各 26 例。两组患者性别、年龄、文化程度、临床痴呆评定量表评定比较差异无统计学意义。所有患者及患者家属均签署知情同意书,并报院伦理委员会批准。

1.2 方法 (1)对照组进行常规出院指导,并解答患者和家属的疑问,出院后不进行任何护理干预。(2)观察组除进行常规出院指导外,护士电话随访 1 次/周,家访 2 次/月,每季度去社区举办健康教育讲座 1 次,并现场指导。干预内容包括:①针对 AD 患者的健康问题,以及照顾者对健康教育知识的需求将自制的 AD 患者健康教育手册和护理技巧手册发放给患者及照顾者,并耐心细致地逐一讲解,直到患者和照顾者满意为止。②心理护理。耐心倾听 AD 患者及照顾者存在的问题,全面评估患者状况,采用多种方法予以帮助、开导和解决,以取得患者和照顾者信任,从而建立良好的护患关系。根据患者不同的个性特点和心理特征,采用个性化心理护理,以求增进患者和家人、亲友交往,使其感受家庭温暖,减少孤独感和心理压力。鼓励患者参加一些力所能及的有益身心健康活动,如读报、种花等,以唤起患者对生活的信心,让照顾者从中了解、熟悉、掌握护理 AD 患者的技巧。③家居安全护理。针对 AD 患者最常见的走失、跌倒、误吸(服)、烫伤、自伤等家居安全问题对患者和照顾者进行相关知识指导。对易走失者需随身携带卡片,卡片上注明姓名、联系人及电话等。对其所居住的家庭环境,要舒适、

安静、整洁安全,以降低家居安全事故的发生率。④康复训练。日常生活能力训练:根据 AD 分期选择患者熟悉且与日常生活方式密切联系的生活内容,训练其自我照顾技巧,如个人卫生、进食、服药等,指导 AD 照顾者护理技巧,以利于提高其日常生活能力及遵医嘱依从性。智能训练:根据患者的条件可进行认图、物品分类、计算等定向力和理解力方面的训练,以刺激大脑思维活动,每次不少于 30 min,要及时鼓励和肯定患者的点滴进步。记忆训练:包括对时间的记忆、事件的记忆、人物的记忆、环境的记忆等。逻辑思维训练:多与患者进行语言交流,寻找其感兴趣的话题,诱导启发患者主动语言表达,以刺激大脑的思维活动。其他:根据 AD 患者的身体状况,选择合适的运动,如打太极拳等,以无不妥为准。此外,嘱患者按时按量服药,同时要讲明药物的作用及注意事项,以确保服药的依从性。

1.3 评定方法 由经过培训的课题组成员制定干预计划和干预指导,分别对 AD 患者于干预前和经过 1 年家庭护理干预后进行 MMSE 量表、日常生活能力量表(activities of daily living, ADL)、健康状况调查问卷(SF-36)评估,分别反映患者的智能、日常生活能力、生活质量的变化。量表间部分有交叉,能较好地反映患者健康状况的真实情况。MMSE 量表总分为 30 分,分数越高说明智能越好。ADL 量表只评定躯体自理能力,共 10 项。总分最低 10 分。表示为完全正常,大于 10 分表示有不同程度的躯体功能下降,最高得分 40 分,表示躯体功能完全丧失。SF-36 问卷包括躯体健康、社会功能、躯体角色功能、躯体疼痛、心理健康、情绪角色功能、精力和总体健康 8 个维度,每个维度初得分需转化为终得分,方可评估其健康水平的变化,8 个维度的终得分之和为综合得分,得分的高低能够直接反映健康状况的好坏^[6-7];每个维度的标准(终得分)总分为 100 分,综合得分总分共 800 分,得分越高,提示健康状况越好,也即生活质量越高。

1.4 统计学处理 本研究属于随机、双盲、平行对照研究。所有资料使用 SPSS 10.0 统计软件对数据进行统计,数据用 $(\bar{x} \pm s)$ 形式的表示。采用 t 检验、 χ^2 检验进行分析,以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组 AD 患者干预前后 MMSE、ADL 评分比较 干预后的观察组患者 ADL 为 (15.86 ± 3.81) 分,高于对照组患者,差异有统计学意义($P < 0.05$, 表 1)。观察组患者 MMSE 得分为 (16.12 ± 2.84) 分,与对照组患者相比差异有统计学意义($P < 0.01$)。

表 1 两组 AD 患者干预前后 MMSE、ADL 评分比较($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	人数	MMSE		ADL	
		干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	26	15.10±2.56	16.12±2.84	14.61±4.61	15.86±3.81
对照组	26	15.32±1.98	14.07±1.63	15.94±3.91	12.61±4.96
<i>t</i>		0.347	3.332	1.075	2.650
<i>P</i>		0.730	0.002	0.287	0.011

2.2 干预后两组患者 SF-36 评分比较 干预后观察组患者在躯体健康、社会功能、躯体角色功能、躯体疼痛、心理健康、情绪角色功能、精力和总体健康 8 个维度及综合评分上与干预后对照组患者的差异有统计学意义($P<0.05$ 或 $P<0.01$, 表 2)。

2.3 干预前后患者自理情况及不安全事件发生情况的比较 对 26 例 AD 患者照顾者进行护理干预后患者在生活自理、误吸、误服、跌倒和走失、激越行为几项上与干预前相比,差异有统计学意义($P<0.05$, 表 3)。

3 讨论

AD 是认知功能障碍、精神衰退、行为异常的一种慢性进行性疾病^[8]。当前我国的相应机构发展不健全,因而 AD 患者大部分时间需在家中受家人照料。老年性痴呆的特征性功能障碍之一为认知功能损害,表现为记忆、语言视空间功能损害及失认、失用,这就要求护士充分发挥家庭、社会功能。课题组成员通过定期电话随访、在社区以患者和家庭(或照顾者)联谊会形式进行个性化健康教育,促进护士、照顾者、AD 患者三者间相互交流,提高、加强对 AD 的认识,使以往以生活护理为主的照顾模式转变成以积极康复为主的全面照顾,延缓 AD 患者病程,为患者创造良好康复环境。据国外研究^[9]报道,无论是否用药,AD 患者的 MMSE 得分会随着年龄增大而减退,未经治疗的患者 MMSE 平均每年约下降 3~4 分。本课题调查结果显示,干预 1 年后两组患者的 MMSE 得分比较差异有统计学意义($P<0.01$)。观察组的智能状态明显优于对照组,可见智能训练可强化患者的思维联想,不仅可给大脑有益刺激,还能加快脑部血液循环及脑细胞的新陈代谢,维持和改善自立能力,延缓记忆力衰退,使 AD 患者的认知水平和行为功能得以保持。干预前后观察组

ADL 得分差异有统计学意义($P<0.01$),对照组的 ADL 无明显变化($P>0.05$),两组患者的 ADL 得分差异有统计学意义($P<0.05$),这表明日常生活能力训练不仅改善了 AD 患者的自理能力和适应能力,使其保持基本生活习惯且能给大脑有益的刺激,使脑部延迟衰退。

AD 是一种慢性渐进性退化痴呆,以慢性进展的智力减退为特征,最终导致无法进行日常生活和人格的持续变化^[10]。倘若日常生活中在护理方面得不到关注,AD 患者的生活质量就会下降,生存期会明显缩短。然而,目前许多家庭照顾者缺乏对该疾病的相关知识和对患者的照料常识,造成 AD 患者在家中不能得到系统、正规的康复护理,这不仅无形中给家庭和社会带来巨大的负担,而且也加速了 AD 的进展。课题组成员对观察组 AD 患者进行家庭护理干预时就其健康问题对 AD 患者和照顾者讲解并通过智能、记忆、逻辑思维、体能和日常生活能力等方面进行干预,其目的是让 AD 患者在日常生活中做力所能及的事,保持生活自理,使其在自我护理中体会到自食其力的快乐和生存的价值,减少对别人的依赖,增加患者复归率。表 2 结果显示,经过 1 年的家庭护理干预后,观察组患者的躯体健康、心理健康和总体评分以及躯体、角色功能、情绪角色功能和社会功能评分均高于干预前和对照组(均 $P<0.01$)。说明 AD 患者接受家庭护理干预后躯体健康、心理健康均有效地得以改善,自理能力得到了提高,角色功能和社会功能也有所改善。

AD 患者由于自控能力的减弱或丧失,家居不安全事件会随时出现,而一旦出现,会给患者、家庭及社会造成严重的影响。表 3 结果显示,对照顾者实施家庭护理干预后,AD 患者家居不安全事件中误吸

表 2 干预后两组患者 SF-36 评分比较($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	躯体健康	躯体角色功能	躯体疼痛	精力	社会功能	情绪角色功能	心理健康	总体健康	综合评分
观察组	62.4±30.5	51.3±8.2	90.0±18.0	66.5±14.9	77.7±23.6	71.8±18.7	80.0±9.9	61.9±13.3	578.3±142.4
对照组	48.2±17.2	18.8±8.9	72.4±18.8	54.0±23.7	64.1±23.3	32.7±10.9	65.9±17.5	43.9±19.3	411.9±148.2
<i>t</i>	2.068	13.694	3.448	2.222	2.091	9.211	3.560	3.916	4.128
<i>P</i>	0.045	0.000	0.000	0.032	0.042	0.000	0.001	0.000	0.000

表 3 对 26 例 AD 患者照顾者
进行护理干预前后患者情况比较(n)

组别	生活自理	误吸	误服	跌倒、走失	激越行为
干预前	12	18	10	8	4
干预后	20	5	2	2	1
χ^2	5.200	13.175	6.933	4.457	0.885
<i>P</i>	0.023	0.000	0.008	0.035	0.347

(服)、跌倒、走失发生率明显降低($P<0.05$),生活自理人数增加($P<0.05$),说明有效的家庭护理干预可明显降低家居不安全事件的发生率,不仅对提高 AD 患者的康复效果有帮助,同时也减轻了家庭负担。激越行为是 AD 患者较常出现的最顽固的行为之一,也是家庭照顾者感到最难应付、加重照顾者负担和精神压力的问题之一^[11]。AD 患者激越行为的发生率达 50%~90%以上^[12],且复杂多样,诱发因素太多^[13],难以应对。虽然表 2 显示其发生率下降,但比较后差异无统计学意义($P>0.05$)。这提示我们在今后家庭护理干预时就 AD 患者激越行为多给照顾者相应指导,使其对 AD 患者护理时采取正确方式,减少或避免激越行为事件的发生。此外照顾者的支持和照顾者对 AD 患者的康复有着举足轻重的作用^[14],故在家庭护理干预中与照顾者建立良好关系,对不同的照顾者给予有针对性的护理指导、积极帮助他们,使照顾者的心态得以调整,并从日常的照顾护理中发现乐趣,提高照顾技巧,对提高 AD 患者的康复效果有促进作用从而延缓 AD 患者的疾病进程。

〔参考文献〕

[1] 盛树力.老年性痴呆及相关疾病[M].北京:科学技术文献出版社,2006:1-4,159-160.

[2] 盛树力.老年性痴呆发病机理研究进展和药物治疗未来战略[J].中国医学科学院报,2004,26(2):101-103.

[3] 张懋奎.老年性痴呆患者的流行病学和预防对策[J].社会医学杂志,2005,3(1):37-38.

[4] 苏海丹,黄春燕,郑越瑜.益智训练对老年痴呆患者认知功能改善的效果观察[J].中国实用护理杂志,2008,24(8):16-17.

[5] 中华医学精神科分会.中国精神障碍分会与诊断标准[M].济南:山东科技出版社,2001:32-34.

[6] 许 军,胡敏燕.健康测量量表 SF-36[J].中国行为医学科学,1999,8(2):150-152.

[7] 王文鹏.SF-36 量表在糖尿病患者生活质量测评中的应用[J].中国临床康复,2002,6(7):932-934.

[8] 王德生.老年性痴呆[M].北京:人民出版社,2001:295-309.

[9] Cockrell J R,Fulstein M F.Minimental state examination[J].Psychopharm Bull,1998,24(4):689-692.

[10]李 静,邹凌燕.老年痴呆病人的护理现状及其展望[J].护理学杂志,2003,18(8):638-639.

[11]周建平.精神分裂症住院患者家属的心理健康干预措施[J].护士进修杂志,2005,20(5):474-475.

[12]Tractenberg R E,Weiner M F,Thal L J.Estimating the prevalence of agitation in community-dwelling persons with Alzheimer's disease[J].J Neuropsychiatry Clin Neurosci,2002,14(1):11-18.

[13]王志稳,肖顺贞,刘 宇,等.社区痴呆患者激越行为应对策略的调查分析[J].中国实用护理杂志,2004,20(3):63-64.

[14]王轶娜,徐 萍,黄晓刚,等.对老年痴呆病人家庭照顾者的护理指导[J].中华护理杂志,2006,41(1):51.

(收稿日期:2009-09-23)
(本文编辑:郁晓路)

(上接第 175 页)

[8] 王红妹,李 鲁,沈 毅.中文版 SF-36 量表用于杭州市区居民生命质量研究[J].中华预防医学杂志,2001,35:428-430.

[9] Ganz P A. Quality of life and the patient with cancer: Individual and policy implication[J]. Cancer, 1994, 74 (4Suppl):1445-1452.

[10] Santos F R, Kozasa E H, Chauffaille M L, et al. Psychosocial adaptation and quality of life among Brazilian patients with different hematological malignancies[J].Psychosom Res,2006,60:505-511.

[11] 管 健.血液病患者心理健康程度的调查研究[J].健康心理学杂志,2003,11(1):5-7.

[12] 周 英,尤黎明,张晋磊,等.急性白血病人心理健康状况及护理[J].中华护理杂志,2002,37:461-462.

[13] 黄 萍,陈利群.住院白血病患者社会支持与生活质量的相关性研究[J].中华护理杂志,2005,40:141-143.

[14] 付 岚,李俊英,李 虹,等.社会支持与癌症患者生活质量的相关性研究及护理对策[J].中华护理杂志,2004,39(1):9-10.

[15] Courtens A M, Stevens F C. Longitudinal study on quality of life and social support in cancer patients[J]. Cancer Nurs,1996,19:162-169.

[16] 李晓波,陈利群.肺癌患者的社会支持[J].中华新医学,2002,3:617-618.

[17] 王 磊,路军章.恶性肿瘤患者生活质量及社会支持状况调查[J].中国康复理论与实践,2008,14:268-269.

(收稿日期:2009-09-23)
(本文编辑:仇瑶琴)